

BỆNH LAO NGHỀ NGHIỆP

Yếu tố gây bệnh

- Yếu tố gây bệnh lao nghề nghiệp là vi khuẩn lao trong môi trường lao động.
- Trực khuẩn lao thuộc loại có khả năng đề kháng tương đối cao với các yếu tố lý hóa so với các vi khuẩn không nha bào khác.
- Trong đờm ả chúng có thể sống được một tháng, trong sữa chúng có thể sống được nhiều tuần.

Đường lan truyền

- Đường hô hấp
- Ăn uống sữa súc vật bị bệnh lao

Chẩn đoán

1. Chẩn đoán xác định

1. Tiền sử nghề nghiệp

2. Triệu chứng

2.1. Lao phổi

2.1. 1. Lâm sàng

2.1.1.1. Triệu chứng cơ năng

- Ho kéo dài trên 2 tuần (ho khan, ho khạc đờm, ho ra máu), đau tức ngực, khó thở, có thể có sốt về chiều.

2.1.1.2. Thực thể

- Nghe phổi có thể có tiếng bệnh lý (rale ẩm to hoặc nhỏ hạt hoặc có rale nổ...).

1.2. Cận lâm sàng

- Lao phổi AFB (+)
- Lao phổi AFB(-)
- Có bằng chứng vi khuẩn lao trong đờm, dịch phế quản, dịch dạ dày bằng phương pháp nuôi cấy hoặc các kỹ thuật mới như genXpert MTB/RIF.
- Được thầy thuốc chuyên khoa chẩn đoán và chỉ định một phác đồ điều trị lao đầy đủ dựa trên lâm sàng, bất thường nghi lao trên X-quang phổi và thêm 1 trong 2 tiêu chuẩn sau: HIV(+) hoặc không đáp ứng với điều trị kháng sinh phổ rộng.
- Lao kê

1.3. Chẩn đoán phân biệt

- Giãn phế quản, viêm phổi, áp xe phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ở người có HIV cần phân biệt chủ yếu với viêm phổi, nhất là viêm phổi PCP

2. Lao ngoài phổi

- Lao ngoài phổi là thể lao khó chẩn đoán
- Các triệu chứng, dấu hiệu ở cơ quan ngoài phổi nghi bị bệnh.
- Lấy bệnh phẩm từ các vị trí tổn thương để xét nghiệm: tìm vi khuẩn lao bằng nhuộm soi trực tiếp, nuôi cấy, genXpert MTB/RIF...
- Mô bệnh tìm tổn thương lao.
- Luôn tìm kiếm xem có lao phổi phối hợp không, nếu có lao phổi sẽ là cơ sở quan trọng cho chẩn đoán lao ngoài phổi.
- Cần luôn chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác

2. 2. Lao ngoài phổi

- Lao ngoài phổi là thể lao khó chẩn đoán
- làm các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán xác định dựa trên:
- Các triệu chứng, dấu hiệu ở cơ quan ngoài phổi nghi bị bệnh.
- Lấy bệnh phẩm từ các vị trí tổn thương để xét nghiệm: tìm vi khuẩn lao bằng nhuộm soi trực tiếp, nuôi cấy, genXpert MTB/RIF...
- Mô bệnh tìm tổn thương lao.
- Luôn tìm kiếm xem có lao phổi phổi hợp không, nếu có lao phổi sẽ là cơ sở quan trọng cho chẩn đoán lao ngoài phổi.
- Cần luôn chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác

3. Chẩn đoán một số lao ngoài phổi thường gặp

3.1. Lao hạch

- Vị trí hay gặp nhất là hạch cổ, điển hình là dọc cơ ức đòn chũm
- Hạch sưng to, lúc đầu hạch chắc, riêng rẽ, di động, không đau sau đó dính vào nhau và tổ chức dưới da, kém di động, hạch nhuyễn hóa, rò mủ.
- Chẩn đoán xác định: chọc hút khoang màng phổi
- Phân biệt: tràn dịch màng phổi do ung thư, suy tim hay viêm mủ màng phổi...
- ***2.3. Lao màng não***
- Bệnh cảnh viêm màng não khởi phát bằng đau đầu tăng dần và rối loạn tri giác.

- Khám: có dấu hiệu cổ cứng, Kernig (+).
- Chọc dịch não tủy: áp lực tăng, dịch có thể trong (giai đoạn sớm), ánh vàng (giai đoạn muộn), có khi vẩn đục.
- *2.4. Tràn dịch màng tim do lao*
- Người bệnh đau ngực, khó thở, tĩnh mạch cổ nổi, phù chi dưới, khám có tim nhịp nhanh, huyết áp kẹt, mạch đảo ngược nếu có ép tim cấp, tiếng tim mờ khi tràn dịch nhiều
- XQ ngực thấy bóng tim to, hình đôi bờ.
- Điện tim có điện thế thấp ở các chuyển đạo, sóng T âm và ST chênh lên
- Siêu âm có tràn dịch màng ngoài tim.

2.5. Lao màng bụng

- Khám có dấu hiệu tràn dịch ổ bụng
- Siêu âm ổ bụng có các gợi ý: hạch mạc treo to, hạch sau màng bụng, hạch khu trú giữa các đám dính, nội soi ổ bụng thấy các hạt lao.
- Chẩn đoán: chọc hút dịch màng bụng màu vàng chanh, đôi khi đục, dịch tiết, chủ yếu tế bào lympho,
- Phân biệt: cổ chướng do xơ gan

2.6. Lao xương khớp

- Hay gặp ở cột sống
- đau lưng, hạn chế vận động, đau tại chỗ tương ứng với đốt sống bị tổn thương (giai đoạn sớm);

- Chụp X-quang, CT, MRI cột sống, khớp thấy hẹp khe đốt, xẹp đốt sống hình chêm,
- Chẩn đoán: dựa vào lâm sàng và các đặc điểm tổn thương trên X-quang, CT, MRI

2.7. Lao tiết niệu - sinh dục

- Hay gặp triệu chứng rối loạn bài tiết nước tiểu (đái buốt, đái rắt) kéo dài từng đợt, điều trị kháng sinh đỡ sau đó lại bị lại, có thể đái máu không có máu cục, đái đục, đau thắt lưng âm ỉ.
- Lao sinh dục nam: sưng đau tinh hoàn, mào tinh hoàn, ít gặp viêm cấp tính, tràn dịch màng tinh hoàn.

- Phân biệt: viêm tiết niệu do xoắn khuẩn.

2.8. Các thể lao khác

- Lao da, lao lách, lao gan... chẩn đoán hoặc có phối hợp với lao phổi hoặc bằng sinh thiết chẩn đoán mô bệnh tế bào.

Phòng bệnh

1. Giải quyết nguồn lây

2. Bảo vệ cơ thể khỏi bị lây

- Tiêm phòng vaccin BCG
- Hóa dự phòng hay còn gọi là điều trị dự phòng,
- Dự phòng trước khi bị nhiễm lao
- Dự phòng sau khi bị nhiễm lao